

Asma

Parents: Distúrbios Obstrutivos

Tags: #Ped #Pneumo

- Doença crônica mais comum na infância;
- Doença heterogênea;

Conceito

Hiperresponsividade e inflamação crônica das vias aéreas.

- Variável em tempo e intensidade (períodos assintomáticos e hipsintomáticos);

Fisiopatologia

- Inflamação → Hiperreatividade brônquica → obstrução das vias aéreas inferiores;

Warning

Asma alérgica ou seja, mediada principalmente por resposta *Th2/IgE*.

- Diferentes fenótipos:
 - Asma alérgica;
 - Tende a ter quadro autolimitado (muito ligado ao TTO adequado).
 - Não alérgica;
 - De início tardio (mais comum em adultos);
 - Relacionada á obesidade;
 - Obstrução fixa;

Asma Alérgica:

- Resposta Th2;
- Eosinofilia;
- Broncoconstrição e hipertrofia do músculo liso brônquico;

Quadro Clínico

#Sibilos #Tosse #Dispneia

- Sibilância;
 - Principalmente expiratório;

⚠ Warning

Sibilância inspiratória e expiratória pode indicar maior gravidade.

- Tosse
 - Geralmente seca;
- Opressão torácica;
- Dispneia;
- Piora á noite e ao despertar;
- Deflagrados por **quadro viral, riso, choro, exercício**;
- Sintomas flutuantes;

❓ Question

Basta a clínica para fazer o diagnóstico de asma?

Não!

Precisamos da **clínica + obstrução respiratória variável**.

- Espirometria com prova broncodilatadora.
 - **Adulto**: VEF1/CVF <0,7 + melhora do VEF1 em >12% E >200 ml após BD;
 - **Criança**: VEF1/CVF <0,9 + melhora do VEF1 em >12%.

i Info

O VEF1/CVF também pode ser chamado de **índice de tiffeneau**;

✗ Limitações da espirometria

- <6 anos;
- Espirometria normal não exclui asma;
- Outros exames:
 - variabilidade diurna no PFE (pico do fluxo expiratório);
 - teste de provocação com metacolina → adultos (devido ao maior risco);
 - peak flow

✓ Atualizou!

O **Gina 2024** passou a considerar o Peak Flow como exame diagnóstico devido á baixa disponibilidade e acesso em alguns países.

Nesse Teste, consideramos a **prova broncodilatadora** como **positiva** com um aumento do Pico de fluxo expiratório $\geq 20\%$ após o uso de broncodilatador de curta duração;

<6 anos

- Diagnóstico muito difícil → baseado na clínica;
- Só 30% dos lactentes sibilantes desenvolvem asma:

Fatores de Risco	
<i>Critérios Maiores</i>	Pai/mãe com asma ou dermatite atópica
<i>Critérios Menores</i>	Rinite Alérgica, sibilância sem resfriado, eosinofilia $\geq 4\%$
Se alta probabilidade	Iniciar teste terapêutico

Manejo da Asma

- Inicialmente devemos identificar se estamos num contexto de asma no ambulatório ou PS.

Ambulatório

1. Passo: Avaliar o controle da Asma do pct:

- Nas últimas 4 semanas:
 - Sintomas diurnos >2x/semana?
 - Medicação de resgate >2x/semana?
 - Despertares noturnos pela asma?
 - Limitações de atividade pela asma?

Note

0: controlada

1-2: parcialmente controlada

3-4: mal controlada

2. Passo: Avaliar o risco de exacerbação independente do controle

- Fatores de risco:
 - Exacerbação no ano anterior;
 - Tabagismo;
 - Má adesão ao TTO/técnica incorreta;
 - Alto uso de SABA (≥ 3 frascos/ano).
 - Comorbidades (obesidade, DRGE).

Por Idade

- Se parcialmente ou mal controlada:
 - Avaliar técnica e adesão;
 - Controle ambiental;
 - Aumentar Step;
- Se bem controlada > 3m:
 - Reduzir step:
 - Avaliar época do ano (evitar no inverno), risco de exacerbações;
- Prescrição obrigatória:
 - Manutenção;
 - Resgate;

Termos

SABA → Short acting beta-2 agonist;

ex: Salbutamol;

LABA → Long acting beta-2 agonist;

Formoterol → LABA de ação rápida (único que pode ser usado como resgate)

Adultos e Adolescentes

- Consenso no uso de **corticóide inalatório** e **formoterol**.

Controle	Step	Manejo
Não controlou	1/2	resgate apenas SOS;
Não controlou	3	CI + formoterol em uso diário
Não controlou	4	CI + formoterol diário dose média
Não controlou	5	Referenciar + Adicionar+ LAMA + Avaliar CI+ formoterol alta dose

 Como avaliar se a dose é alta, média ou baixa?

Corticoide	Tipo de dispositivo	Dose baixa† mcg/dia	Dose média mcg/dia	Dose alta†† mcg/dia
Dipropionato de beclometasona	DIP, HFA	200-500	>500- 1.000	>1.000
Dipropionato de beclometasona	HFA partícula extrafina	100-200	>200-400	>400
Budesonida	DPI, HFA	200-400	>400-800	>800